

药物相互作用三则

(一) 食物对心痛定药代动力学的影响

通过15名健康的受试者,按禁食、低脂肪饮食、高脂肪饮食三种标准分成三个小组测试,用120ml水送服10mg心痛定胶囊,观察4天,以确定食物对心痛定潜在的相互作用。

口服心痛定后每隔8小时取血样检查:0—8小时曲线下面积、0—无穷大的曲线下面积以及清除半衰期不同的饮食引起的变化不显著。最高血药浓度,禁食者为78.9ng/ml,低脂肪饮食为42.2ng/ml,高脂肪饮食为58.7ng/ml,到达最高血药浓度所需的时间依次为0.97、1.89、1.07小时,变化显著。

由此可见,饮食方式对心痛定的吸收速度(不是吸收程度)有较大的影响,但采取合适的饮食方式,可以减少心痛定服用后兴奋、头痛等副作用。

(二)、在妇科小手术中安定与缓释安定术前的对比研究

60名年龄在18—60岁之间接受妇科小手术的病人,手术前服用普通安定和缓释安片(10mg/片)做对比试验。

病人于手术前一天晚上服用1片缓释安定,或于手术前的当天早晨服用1片普通安定。服用缓释安定的病人比接受安慰剂的病人经历的觉醒时间要短,术前早晨服用普通安定比手术前一天晚上服用缓释安定对病人

催眠时间相应要长。

由此可见,缓释安定作为一种夜间催眠药物是有效的。然而,作为一种手术前的镇静药,与普通安定相比,并未表现出更多的优越性。

(三)、乙胺碘呋酮与华法令相互作用

药物用量和时间过程

8名39—70岁的心脏病人,每日服用乙胺碘呋酮200—400mg和华法令,结果致使凝血酶原时间延长。(译者注:原文未写华法令剂量)

这些病人的其它治疗用药还包括:心得安、氯磺丙脲、地戈辛、速尿、强的松、氯压定、蔗糖硫酸碱式铝盐、潘生丁、甲氧乙心安、及左旋甲状腺素钠。

头两周内,服用乙胺碘呋酮,患者的平均凝血酶原时间最高值增加了44%。6名病人华法令用量减少35%,4—8星期乙胺碘呋酮治疗后,凝血酶原时间下降至基础量的15%以内。两名患者,尽管华法令用量分别减少了33%,第8周时凝血酶原时间改变在基础量的15%以上。在这个期间,也许由于认识较早并及时采取降低剂量的预防措施,本试验的病人没有遇到抗凝血治疗的并发症,作用机理仍不清楚。

曹建红摘译自《International Pharmaceutical Abstracts》1988, 25: 1418; 1988, 25, 1512; 1989, 26, 233 朱永宏校